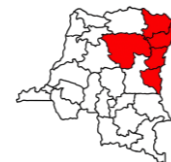




TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17^{ème} Épidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°105/MVEBDB/27/08/2026

Date de rapportage : 27 août 2026

Date de publication : 28 août 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

Au terme de la journée du 27 août 2026, 69 nouveaux cas confirmés dont 23 décès communautaires de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été enregistrés dans les provinces de l'Ituri (43 cas), du Nord-Kivu (13 cas), Haut Uélé (11) et Tshopo (2). De plus, 15 décès intra-CTE ont été enregistrés.

Aucune nouvelle zone de santé touchée au cours de dernières 24h.

CUMUL DES CAS 5 863	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS 2 824	LETALITE 48,2%	PATIENS EN ISOLEMENT/CTE 795	CUMUL DES GUÉRIS 1 318	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour) 87,3 %
--	--	-------------------------------------	---	---	---



Provinces touchées et Zones de santé touchées



6 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé



60 Zones de santé touchées sur 151

(39,7%)



Résumé des points clés au cours de dernières 24 heures

Pour la journée du 27 août 2026, **69 nouveaux cas confirmés** dont **23 décès communautaires** de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été rapportés dans les provinces de l'Ituri (**43 cas**), Nord-Kivu (**13**), Haut Uélé (**11**) et Tshopo (**2**).

D'autre part, **25 patients** ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE (22 en Ituri, 2 au Haut Uélé et 1 au Nord Kivu). De plus, **15 décès intra-CTE** ont été enregistrés, dont 12 en Ituri, 2 au Nord Kivu et 1 au Haut Uélé. Ce qui porte **le nombre des décès du jour à 38**.

Depuis le début de l'épidémie jusqu'au 27 août 2026, **5 863 cas confirmés** dont **2 824 décès** ont été rapportés en RDC, soit une létalité de **48,2 %**. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant **82,6 %** des cas confirmés cumulés et **62,3 %** des nouveaux cas rapportés.

Globalement, 60 des 151 zones de santé des six provinces restent affectées depuis le début de l'épidémie en RDC. L'Ituri compte 28 zones de santé touchées sur 36, suivi du Nord-Kivu (15/34), du Haut-Uélé (6/13), de la Tshopo (7/23), du Sud-Kivu (1/34) et Bas Uélé (3/11).

Répartition des cas et décès confirmés par province touchée
(Au 27 août 2026)

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	43	4845	2 185	45,1%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	13	788	538	68,3%	15/34 (44,1 %)
Haut-Uélé	11	205	91	44,4%	6/13 (46,1 %)
Tshopo	2	19	8	42,1%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas Uélé	0	3	1	33,3%	3/11(27,3%)
Total	69	5 863	2 824	48,2%	60/151 (39,7 %)

Cas et décès confirmés par province et zone de santé (situation du 27 août 2026)

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	4845	2185	45,1%	43	14	12	26
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	7	6	85,7%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	156	34	21,8%	7	5		5
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1347	424	31,5%	11	3		3
Damas	27	9	33,3%				0
Drodro	13	6	46,2%				0
Fataki	74	30	40,5%	1	0		0
Gethy	6	2	33,3%	1	0		0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	32	12	37,5%				0
Komanda	69	46	66,7%	4	4		4
Lita	208	111	53,4%	4	0		0
Logo	11	5	45,5%				0
Lolwa	19	4	21,1%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	17	7	41,2%				0
Mandima	33	19	57,6%				0
Mangala	213	114	53,5%	1	0		0
Mongbwalu	606	284	46,9%				0
Nia-Nia	203	108	53,2%	4	0		0
Nizi	640	256	40,0%	4	2		2
Nyankunde	124	35	28,2%				0

Rimba	10	4	40,0%				0
Rwampara	935	336	35,9%	5	0	0	0
Tchomia	56	25	44,6%	1	0		0
A ventiler	NA	297	NA	NA	NA	12	12
Nord-Kivu	788	538	68,3%	13	9	2	11
Beni	126	91	72,2%	4	3	1	4
Biena	1	1	100,0%				0
Butembo	155	118	76,1%	3	2	0	2
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	16	7	43,8%				0
Katwa	373	250	67,0%	5	4	0	4
Kyondo	16	12	75,0%				0
Lubero	1	1	100,0%				0
Mabalako	3	2	66,7%				0
Manguredjipa	1	0	0,0%				0
Masereka	8	4	50,0%	1	0	0	0
Musienene	74	43	58,1%				0
Mutwanga	1	1	100,0%				0
Oicha	7	6	85,7%	0	0	1	1
Vuhovi	5	2	40,0%				0
Haut-Uélé	205	91	44,4%	11	0	1	1
Boma							
Mangbetu	26	14	53,8%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	79	33	41,8%	1	0	1	1
Pawa	24	16	66,7%	4	0	0	0
Rungu	1	0	0,0%				0
Wamba	72	27	37,5%	6	0	0	0
Tshopo	19	8	42,1%	2	0	0	0
Bafwasende	2	0	0,0%	1	0	0	0
Kabondo	3	1	33,3%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	9	4	44,4%	1	0	0	0
Mangobo	2	2	100,0%				0
Tshopo	1	0	0,0%				
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	3	1	33,3%	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	1	0	0,0%				
Ganga	1	0	0,0%				
Total	5863	2824	48,2%	69	23	15	38

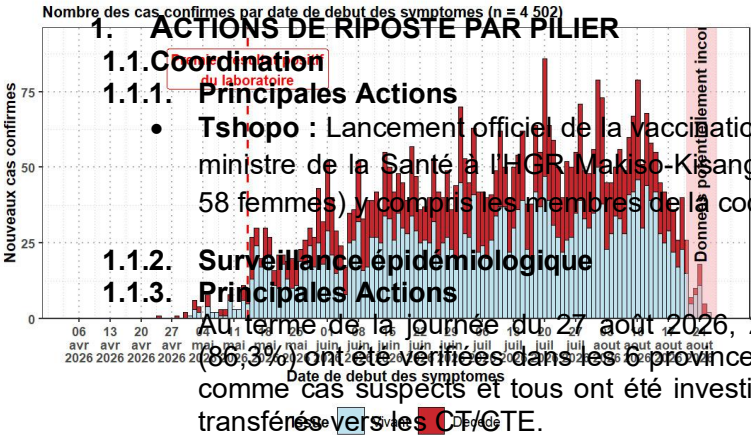
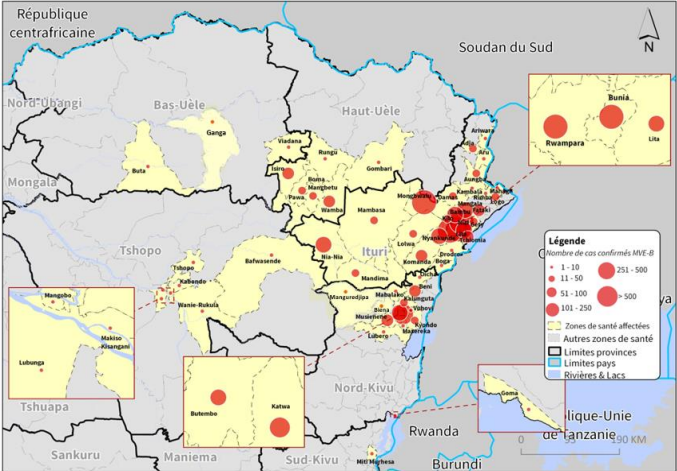
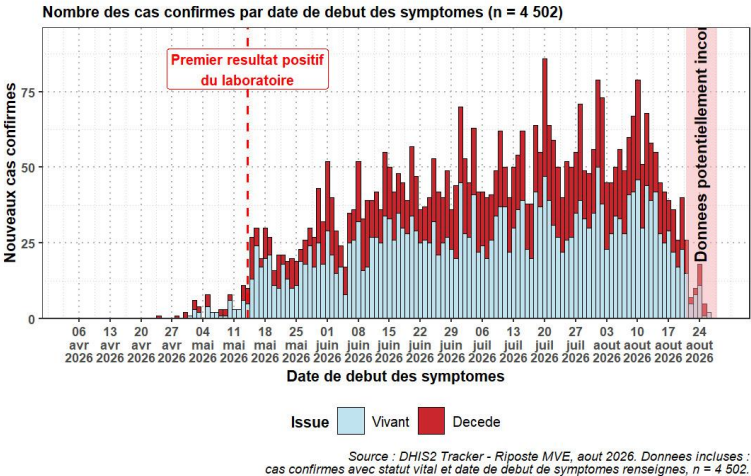
*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province et sont en cours de ventilation pour être classifié par zone de santé.

NA : Non Applicable.

Province / Nombre cumulatif Situation du jour (24h)									
DPS	Nouvelles Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	14	5	19	14	5	0	0	19	14
Bas Uélé	16	4	20	5	4	11	0	9	0
Ituri	788	76	864	134	70	401	2	204	120
Nord-Kivu	932	64	996	97	63	814	1	160	71
Sud-Kivu	4	0	4	0	0	4	0	0	0
Tshopo	130	0	130	8	0	122	0	8	8
Total Général	1884	149	2 033	258	142	1352	3	400	213

Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours

CARTOGRAPHIE DES CAS de 21 derniers jours



1. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

1.1.Coordination

1.1.1. Principales Actions

- **Tshopo** : Lancement officiel de la vaccination des personnes de première ligne (PPL) par le ministre de la Santé à l'HGR-Makiso-Kiangani ; 122 personnes vaccinées (64 hommes et 58 femmes) y compris les membres de la coordination du SGI.

1.1.2. Surveillance épidémiologique

1.1.3. Principales Actions

Au terme de la journée du 27 août 2026, 2 033 alertes ont été enregistrées, dont 1 755 (86,3%) ont été vérifiées dans les provinces touchées. Ainsi, 400 (22,8 %) ont été validées comme cas suspects et tous ont été investigués, soit 100,0 %, parmi lesquels 213 ont été transférés vers les CT/CTE.

La proportion des contacts suivis au cours des dernières 24 heures se situe à 87,3 % (24 769 vus sur 28 372 à suivre), au-dessus du seuil de 85 % : Ituri 89,9 % (15 712/17 477), Tshopo 76,9% (306/398), Nord-Kivu 84,0 % (7 371/8 770), Haut Uélé 84,0% (1 200/1 429) et Bas Uélé 60,4% (180/298).

1.1.4. Défis

Persistance d'un faible suivi des contacts autour des cas confirmés dans la province du Bas Uélé lié à une insuffisance des équipes dédiées à ces activités.

1.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoC/PoE)

1.2.1. Principales actions

- Sept (7) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC au cours des dernières 24 heures : une en Ituri au PoC Mudzi Bala (ZS Bunia), validée, isolée et référée au CT Elikia ; six au Nord-Kivu aux PoC Foner Kasindi et PoE Kasindi (ZS Mutwanga), dont quatre validées et référées, et deux invalidées après investigation. Aucun corps sans vie n'a été intercepté au cours des dernières 24 heures.

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Tshopo	Haut-Uélé	Bas-Uélé	Global
Complétude des rapports	96,7 % (58/60)	100 % (18/18)	55,6 % (5/9)	71,4 % (5/7)	72,7 % (8/11)	ND	89,5 % (94/105)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	9,09 % (1/11)	100 %	NA	35 % (7/20)	54,5 % (6/11)	ND	ND
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	145 866	89 286	9 668	5 177	11 783	ND	261 780
% des voyageurs screenés	97,8 %	98,0 %	98,4 %	99,3 %	98,8 %	ND	98,0 %
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,5 %	98,0 %	98,4 %	99,1 %	98,7 %	ND	97,8 %
% des voyageurs sensibilisés	99,5 %	98,0 %	100 %	100 %	98,7 %	ND	99,0 %
Nombre d'alertes notifiées	1	6	0	0	0	ND	7
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	1	4	0	0	0	ND	5
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	0	0	0	0	ND	0
% des cas suspects transférés au CT/CTE	100 % (1/1)	100 % (4/4)	NA	0 %	0 %	ND	100 % (5/5)
% des corps sans vie swabés/sécurisés	0 % (0/0)	0 % (0/0)	NA	0 %	0 %	ND	0 % (0/0)
% des cas suspects investigués dans 24 h	100 % (1/1)	100 % (4/4)	NA	0 %	0 %	ND	100 % (5/5)

1.2.2. Défis

Opérationnalisation insuffisante des PoE/PoC : la complétude globale se situe à 89,5 % (94 rapports sur 105), avec des niveaux faibles au Sud-Kivu (55,6 %), à la Tshopo (71,4 %) et au Haut-Uélé (72,7 %). En Ituri, 1 (9,09 %) des 11 PoE/PoC stratégiques fonctionne sans interruption et le PoC d'Avakubi reste non fonctionnel pour raisons sécuritaires. Au Haut-Uélé, 3 PoC (Dusu, Apodo et Aungba) n'ont pas transmis leurs données ; refus au screening et de lavage des mains de certains voyageurs.

1.3. Laboratoire

1.3.1. Principales actions

- **Ituri : 43 nouveaux résultats positifs** (29 vivants et 14 décès) sur 292 nouveaux échantillons reçus et analysés (**positivité : 14,7 %**).
- **Tshopo : 2 nouveaux résultats positifs ont été enregistrés sur 8 échantillons (positivité : 25%)**.
- **Nord-Kivu : 13 nouveaux résultats positifs** (5 vivants et 8 décès) sur 185 échantillons analysés (**positivité de 7,0%**).
- **Haut-Uélé : 11 nouveaux résultats positifs** (11 vivants et 0 décès) sur 11 échantillons analysés (**positivité est de 100 %**).
- **Bas-Uélé : 2 échantillons reçus et testés à Buta, aucun résultat positif.**

1.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

1.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 27 rings ont été ouverts sur les 52 identifiés (51,9 %), 123 ménages décontaminés sur 141 identifiés (87,2 %) et 4 FOSA sur 4 (100 %) ; 15 kits ont été dotés aux ménages. Le pilier EDS a reçu 98 alertes (dont 5 reports) : 66 corps swabés, 77 EDS réalisés au terme de la journée.
- **Au Nord-Kivu**, 13 FOSA sur 13 ont été décontaminées (100 %), 1 ring a été ouvert sur les 22 identifiés (4,5 %) et 2 ménages décontaminés sur 22 (9 %) ; 8 FOSA ont été évaluées (score moyen inférieur à 50 %) et aucun kit PCI n'a été doté aux ménages. Le pilier EDS a reçu 52 alertes : 52 corps swabés, aucun échec, 50 EDS réalisés.
- **À la Tshopo**, Suivi et accompagnement de 15 ESS dans 5 ZS (Makiso-Kisangani, Mangobo, Tshopo, Kabondo et Lubunga) dont 158 prestataires ont été briefés sur la mise en oeuvre des mesures PCI ; Décontamination des locaux de la Polyclinique ART.

1.4.2. Défis

- Faible mise en œuvre des normes de PCI : en Ituri, l'ouverture des rings reste limitée à 51,9 % et échecs de swab ont été enregistrés ; insuffisance d'équipes de décontamination à Fataki et Mangala et manque de mobilité à Komanda, Bambu et Mangala.
- Au Nord-Kivu, aucune décontamination des lieux de séjour des cas confirmés n'a été réalisée et les équipes de décontamination font défaut dans les ZS nouvellement touchées.
- À la Tshopo, insuffisance d'EPI dans les ESS et panne de l'incinérateur de l'HGR Makiso-Kisangani.

1.5. Continuité des soins

1.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 119 nouvelles admissions ont été enregistrées et 105 sorties dont 22 guéris. Ainsi, 522 patients sont hospitalisés pour 978 lits, soit un taux d'occupation global de 53,4 %.
- **Au Nord-Kivu**, 89 admissions ont été enregistrées contre 42 sorties dont 1 guéri. Au terme de la journée, 232 patients sont hospitalisés pour 220 lits, soit un taux d'occupation global de 105,5 %.
- Au Bas Uélé, 1 patient confirmé est en cours de soins (Taux d'occupation : 25,0%).
- Au Haut Uélé, 2 nouveaux guéris ont été déchargés.
- **Au Sud-Kivu**, 26 cas suspects sont isolés dans les CT de Lwiro (13), FOMULAC (8), CUB (3) et Nyangezi (2).

1.5.2. Défis

Faible capacité d'accueil et absence de CTE dans certaines zones de santé : saturation du CTE de Bambu (confirmés) et du CT Kigonze (suspects) en Ituri ; dépassement de la capacité en lits suspects au Nord-Kivu, où une partie des suspects de Butembo, Masereka, Vuhovi et Kalunguta est isolée dans des ESS qui ne sont pas des centres de traitement ; à la Tshopo, capacité d'accueil du CTE limitée à 14 lits.

1.6. Communication sur les risques et engagement communautaire

1.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, 120 personnes ont été touchées autour des cas confirmés (80 à Rwampara et 40 à Nia-Nia) ; 2 causeries éducatives (40 personnes dont 15 femmes) et 1 séance de sensibilisation de masse (31 personnes dont 19 femmes) ; 7 EDS facilitées et 7 ménages décontaminés à Rwampara ; 71 contacts listés avec l'appui du CREC à Nia-Nia et 5 contacts référés.
- **À la Tshopo**, 2 006 personnes sensibilisées (1 151 femmes et 855 hommes), 987 dépliants distribués et 15 banderoles placées ; 1 rumeur clarifiée.
- **Au Nord-Kivu**, communication de proximité autour de 19 cas confirmés et 88 chefs de ménage touchés (Katwa 9 cas/28 ménages, Butembo 2/9, Lubero 2/14, Beni 1/11, Kyondo 1/12, Masereka 1/5, Kalunguta 1/4, Vuhovi 1/3 et Mabalako 1/2) ; 4 incidents communautaires résolus et 17 rumeurs clarifiées.
- **Au Haut-Uélé**, 4 nouveaux cas confirmés (3 à Isiro et 1 à Pawa) et 23 cas confirmés en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 6 nouveaux suspects et 6 suspects en cours de suivi ; 48 accompagnants et 27 PPL ont été soutenus, 18 annonces de résultats réalisées dont 6 positives et 1 EDS appuyé ; suivi du déchargement de 3 guéris à Pawa.

1.6.2. Défis

Persistance des défis au niveau communautaire : en Ituri, refus de prélèvement à Nia-Nia et Alimasi, réticence à Kabakaba et refus de listage des contacts à Kilo État (48 cas) ; au Nord-Kivu, résistances communautaires à Katwa, Butembo, Kalunguta et Beni et assassinat d'un président de cellule d'animation communautaire dans l'AS Mangothe (ZS de Beni) ; à la Tshopo, résistances aux investigations, prélèvements et transferts au CTE.

1.7. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

1.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, 23 cas parmi les nouveaux confirmés et 148 des 220 cas confirmés en cours de suivi (67,2 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 41 des 115 nouveaux suspects (35,7 %) et 116 des 157 suspects en cours de suivi (73,9 %) ; 50 ménages ont été accompagnés, 42 PPL soutenus, 18 enfants suivis en communauté et 7 en crèche ; 67 annonces de résultats ont été réalisées dont 23 positives et 17 guéris sur 22 (77 %) ont été réinsérés. La couverture reste limitée à 5 des 9 ZS ayant notifié (56 %).
- **Au Nord-Kivu**, 16 cas parmi les nouveaux confirmés et 98 des 121 nouveaux suspects (80,0 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 90 annonces de résultats ont été réalisées dont 20 positives, 82 ménages accompagnés, 64 PPL soutenus, 14 enfants suivis en communauté et 1 en crèche, et 1 guéri réinséré (100 %).
- **Au Haut-Uélé**, 4 nouveaux cas confirmés (3 à Isiro et 1 à Pawa) et 23 cas confirmés en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 6 nouveaux suspects et 6 suspects en cours de suivi ; 48 accompagnants et 27 PPL ont été soutenus, 18 annonces de résultats réalisées dont 6 positives et 1 EDS appuyé ; suivi du déchargement de 3 guéris à Pawa.

1.7.2. Défis

Au Haut Uélé, couverture SMSPS insuffisante. **Au Nord-Kivu**, seules 4 ZS sont couvertes par des interventions autour des derniers cas et les crèches font défaut dans les CTE. **En Ituri**, aucune couverture à Bambu, Nia-Nia, Mambasa et Lolwa.

1.8. Logistique

1.8.1. Principales actions

Dans la Tshopo, appui à la mobilité aux différents piliers PCI, PECH, Communication, PoE/PoC et vaccination et Suivi de la Construction des isolements (KONGA KONGA) et du CTE de grande capacité.

Au Nord-Kivu, couverture sécuritaire des équipes PCI dans les AS de Butsili.

1.9. Sécurité

1.9.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, couverture sécuritaire des équipes PCI dans les AS de Butsili, Madrandele et Kanzunzulili ainsi qu'au CS Nyakunde ; accompagnement de l'équipe EDS au cimetière de Bundji pour l'enterrement de 4 corps de cas confirmés et pour des swabs au CH Peregrin et au CH Don Divin ; supervision et évaluation sécuritaire au PoE Kyaghala et au PoC Kitakandi.

1.9.2. Défis

La sécurisation des PoC stratégiques reste incomplète : au Haut-Uélé, le corps sans vie intercepté au PoC de Magambe (ZS Isiro) a été relâché par la sécurité sans avoir pu être swabé. Au Nord-Kivu, l'insécurité persiste dans les zones d'enterrement et la route menant au cimetière de Bundji (ZS de Beni) reste impraticable.

1.10. PSEA (Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels)

1.10.1. Principales actions.

En Ituri, formation et briefing de 22 participants (16 hommes et 6 femmes) sur la PSEAH lors de la formation de la prise en charge (ZS Bunia) ; sensibilisation de 128 personnes dans les AS de Mudzimaria (93 participants) et de Bigo (35 participants) ; poursuite de l'affichage des messages et de la distribution de dépliants dans les ZS de Bunia, Aru, Rwampara et Mongbwalu.

1.10.2. Défis

- Couverture encore insuffisante des activités PSEA : 25 % des zones de santé de l'Ituri (9/36) connaissent le mécanisme de signalement et seuls 2 partenaires (OMS et IMC) rapportent leurs activités PSEA ; absence de cartographie des intervenants ; insuffisance de supports de sensibilisation de masse ; manque de moyens de transport et d'équipement informatique pour le pilier.

MESSAGES CLES

- La transmission de la MVE reste active, avec 69 nouveaux cas dont 23 décès communautaires et 15 intra- CTE enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le cumul national à 5 863 cas confirmés et 2 824 décès.
- L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 82,6 % des cas confirmés cumulés et 62,3% des nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24 heures et une expansion plus importante (28 des 36 ZS affectées).
- La surveillance affiche une bonne performance (100%) des cas suspects investigués tandis que le taux de suivi (87,3%) est au-dessus du seuil de 85,0%.
- Le renforcement des interventions prioritaires (surveillance, prise en charge, PCI, logistique et engagement communautaire) demeure essentiel pour interrompre rapidement les chaînes de transmission.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr Kombe NGWAMA John

Equipe rédaction

Professeur Dr Mulangu Katulumba Félix-Médard

Dr Katusi Biselenge Jules

Madame Mayele Afua Marie

Dr Diur Mananashi Floryan

Mr Kamuina Kebela John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd